

CAPÍTULO 11.10

Glomerulonefritis y Síndrome Nefrítico

PERFIL EUNACOM 1.06.1.011

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Glomerulonefritis y Tipos

Diagnóstico de Glomerulonefritis

- **Sedimento urinario:** Hematuria **dismórfica** (acantocitos) y/o cilindros hemáticos/eritrocitarios.
- Patognomónico de origen glomerular.

Formas Clínicas de Presentación

TABLA 11.10.1: PRESENTACIÓN VS CARACTERÍSTICAS	
PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS
Microhematuria	Solo acantocitos en sedimento (asintomático)
Macrohematuria	Orina visiblemente sanguinolenta (ej: nefropatía por IgA)
Síndrome nefrítico	Tríada: Hematuria + HTA + Edema
GNRP (Rápidamente Progresiva)	GN + ↓ CrCl ≥ 50% en < 3 meses
Síndrome nefrótico impuro	Nefrótico + hematuria / HTA / IRA

Clasificación por Complemento

TABLA 11.10.2: TIPO VS COMPLEMENTO		
TIPO	COMPLEMENTO	ENFERMEDADES
Hipocomplementémicas	↓ C3/C4	GN post-estreptocócica (GNAPE), LES, Crioglobulinemia, GN Mesangiocapilar
Normocomplementémicas	Normal	Nefropatía IgA, Vasculitis, Anti-MBG (Goodpasture)

Clasificación por Inmunofluorescencia (Biopsia)

TABLA 11.10.3: PATRÓN VS ASOCIADO A	
PATRÓN	ASOCIADO A
Lineal	Enfermedad anti-membrana basal (S. Goodpasture)
Granular	Complejos inmunes (GNAPE, LES, IgA)
Pauci-inmune (poca fluorescencia)	Vasculitis (PAM, Granulomatosis con poliangeítis / Wegener)

Tipos Específicos

TABLA 11.10.4: GN VS FRECUENCIA / CLAVE CLÍNICA	
GN	FRECUENCIA / CLAVE CLÍNICA
Nefropatía por IgA (Berger)	GN más frecuente. Hematuria concomitante a infección viral (no días después). Normocomplementémica.
GNAPE (post-estreptocócica)	GN nefrítica más frecuente. 1-2 semanas post-faringitis/impétigo. Hipocomplementémica. Tratamiento: soporte.
GN Mesangiocapilar	Hipocomplementémica. Clínica variable. Puede confundirse con LES o GNAPE.
Crioglobulinemia	Hipocomplementémica. Asociada a VHC. Púrpura palpable + artritis + neuropatía distal en zonas frías.
LES	Hipocomplementémica. GN + clínica sistémica de lupus.
Vasculitis (PAM, Wegener, Churg-Strauss)	Normocomplementémica. Pauci-inmune. Frecuentemente GNRP con falla renal grave.
Anti-membrana basal (Goodpasture)	Síndrome riñón-pulmón: GN + hemoptisis/alveolitis. Patrón lineal.

Estudio de GN

- **Función renal** (clearance, BUN, proteinuria)
 - **Complemento C3/C4**
 - **ANA** (lupus), **ANCA** (vasculitis), **Anti-MBG** (Goodpasture)
 - **Biopsia renal** (casi siempre, salvo GNAPE típica sin falla renal)
- > **Única excepción a la biopsia:** Clínica típica de GNAPE + complemento bajo + SIN falla renal.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niño de 8 años presenta edema, hipertensión y hematuria macroscópica 2 semanas después de una amigdalitis. El complemento C3 está disminuido y la creatinina es de 1.1 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Glomerulonefritis y Síndrome Nefrítico. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Diagnóstico de GN: hematuria dismórfica (acantocitos) o cilindros hemáticos en sedimento urinario.
- Formas de presentación: síndrome nefrítico, micro/macrohemia aislada, nefrítico impuro, GNRP.
- Síndrome nefrítico: tríada obligatoria de hematuria + hipertensión + edema.
- Hipocomplementémicas: GNAPE, posinfecciosas, lupus, crioglobulinemia, mesangiocapilar.
- Normocomplementémicas: nefropatía por IgA, vasculitis, anti-membrana basal.
- Estudio: función renal + perfil inmunológico (C3/C4, ANA, ANCA, anti-MB) + biopsia renal.
- Biopsia renal en casi todos los casos. Excepción: GNAPE probable sin falla renal grave.
- Si sospecha de GNAPE pero tiene creatinina elevada (ej. 2 o más), se biopsia igual.
- GNAPE: GN con síndrome nefrítico más frecuente. Nefropatía por IgA: GN más frecuente en general.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (GLOMERULONEFRITIS Y SÍNDROME NEFRÍTICO)**PREGUNTA 1**

Niño de 8 años presenta edema, hipertensión y hematuria macroscópica 2 semanas después de una amigdalitis. El complemento C3 está disminuido y la creatinina es de 1.1 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Biopsia renal urgente

B) Tratamiento de soporte y observación sin biopsia

C) Corticoides en dosis altas

D) Iniciar diálisis preventiva

E) Iniciar IECA para proteinuria

PREGUNTA 2

Paciente de 35 años con hematuria dismórfica, hipertensión, edema y creatinina de 5.5 mg/dL. ANCA positivos, complemento normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica

B) Nefropatía por IgA

C) Vasculitis de vaso pequeño (GNRP)

D) Enfermedad de Goodpasture

E) Crioglobulinemia

PREGUNTA 3

¿Cuál de las siguientes glomerulonefritis es hipocomplementémica?

A) Nefropatía por IgA (enfermedad de Berger)

B) Vasculitis de vaso pequeño

C) Enfermedad por anticuerpos anti-membrana basal

D) Glomerulonefritis mesangiocapilar

E) Glomerulosclerosis focal y segmentaria

RESUMEN: GLOMERULONEFRITIS Y SÍNDROME NEFRÍTICO

La glomerulonefritis se diagnostica con sedimento urinario que muestra hematuria dismórfica (acantocitos) o cilindros hemáticos/eritrocitarios. Se puede manifestar como síndrome nefrítico (triada de hematuria, hipertensión y edema), microhematuria aislada, macrohematuria, síndrome nefrótico impuro (siempre impuro por la hematuria), falla renal (glomerulonefritis rápidamente progresiva si el clearance cae más del 50% en menos de 3 meses). El tratamiento es tratar la causa, corticoides en algunas (lupus), soporte en otras (GNAPE). El estudio incluye función renal, perfil inmunológico (complemento C3/C4, ANA, ANCA, anti-membrana basal) y biopsia renal. La biopsia se realiza en casi todos los casos, excepto cuando todo apunta a GNAPE y el paciente está sin falla renal grave. Las glomerulonefritis hipocomplementémicas incluyen la postestreptocócica (la más importante), posinfecciosas, lupus, crioglobulinemia y mesangiocapilar. Las normocomplementémicas incluyen nefropatía por IgA, vasculitis y enfermedad por anticuerpos anti-membrana basal.